UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

PÉDIATRIE / DERMATOLOGIE
HÉMANGIOME
SANS PATIENT
SANS GESTE CLINIQUE

Nom du rédacteur : (Evan Debarbat) **Date de rédaction : Décembre 2023**

Relecture intra ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° (90) – Tâche cutanée du nourrisson

Domaine de compétence principal (en sélectionner 1 SEUL) : Iconographie

Domaine de compétence secondaire (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie diagnostique

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Décrire les caractéristiques sémiologiques de la ou des "tâche(s)"

2- Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnostiques.

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Instructions à l'étudiant

Vous êtes pédiatre dans votre cabinet de consultation, un externe du service vous interroge sur la photo d'une «tâche» pigmentée cutanée d'un nourrisson, apparue après la naissance.

(PAS DE PATIENT)

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Donner le diagnostic le plus probable.
2. Décrire l'examen clinique à réaliser et expliquer les caractéristiques cliniques à rechercher.
3. Donner les évolutions possibles de cette lésion ainsi que les différents traitements possibles.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce le diagnostic d'hémangiome superficiel.	
Tache 2	
Décrit la recherche d'autres localisations de ces lésions sur un nourrisson déshabillé.	
Explique qu'une palpation est nécessaire.	
Explique qu'une auscultation est nécessaire.	
Décrit une tuméfaction de consistance élastique	
Décrit une tuméfaction sans frémissement à la palpation et sans souffle à l'auscultation *OK si ½*	
Explique que la tuméfaction pâlit à la pression, sans vidange ni disparition complète *OK si 1/3*	
Tache 3	
Décrit l'évolution la plus fréquente (*croissance durant les 6 premiers mois, puis involution spontanée en 2 à 10 ans).*	
Cite les principales complications : *ulcération / amblyopie / séquelle esthétique / obstruction laryngée ou trachéale OK si 2/4*	
Explique qu'une involution spontanée est le plus probable, ne nécessitant alors aucun traitement.	
Évoque le traitement par propanolol per os en cas d'hémangiome évolutif volumineux ou mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel.	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce le diagnostic d'hémangiome superficiel.	1
Tache 2	
Décrit la recherche d'autres localisations de ces lésions sur un nourrisson déshabillé.	1
Explique qu'une palpation est nécessaire.	1
Explique qu'une auscultation est nécessaire.	1
Décrit une tuméfaction de consistance élastique	1
Décrit une tuméfaction sans frémissement à la palpation et sans souffle à l'auscultation *OK si ½*	1
Explique que la tuméfaction pâlit à la pression, sans vidange ni disparition complète *OK si 1/3*	1
Tache 3	
Décrit l'évolution la plus fréquente (*croissance durant les 6 premiers mois, puis involution spontanée en 2 à 10 ans).*	1
Cite les principales complications : *ulcération / amblyopie / séquelle esthétique / obstruction laryngée ou trachéale OK si 2/4*	1
Explique qu'une involution spontanée est le plus probable, ne nécessitant alors aucun traitement.	1
Évoque le traitement par propanolol per os en cas d'hémangiome évolutif volumineux ou mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel.	1
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	
	1 à 5

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-113-02-A
Item parent	Hémangiomes et malformations vasculaires cutanées
Rang	A
Intitulé	Connaître les signes cliniques d'un hémangiome
Description	None
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Sophie Blaise
Ordre	2

1- Diagnostic clinique (biopsie et imagerie généralement inutiles).

- Tuméfaction de consistance élastique (non dure) sans frémissement à la palpation ni souffle à l'auscultation.
- Taille, nombre et siège variables.

Trois types cliniques d'hémangiome :

- *Hémangiome superficiel* (= nodule ou une plaque rouge vif (figure 113.2), en relief, à surface tendue ou mamelonnée, sans vidange ni disparition complète à la pression.
- *Hémangiome profond* (ou sous-cutané) = tuméfaction bleutée ou de la couleur de la peau normale (imagerie parfois nécessaire : l'échographie-Doppler montre une tumeur richement vascularisée à flux rapide).
- *Hémangiome mixte* associe les composantes superficielle et profonde (figure 113.3).

Fig 113.2: hémangiome superficiel

Figure 113.3 : hémangiome mixte

Connaître les principaux diagnostics différentiels des hémangiomes OIC-113-03-B

ANNEXE : FICHE LISA

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-113-04-A
Item parent	Hémangiomes et malformations vasculaires cutanées
Rang	A
Intitulé	Connaître les localisations à risque et les complications des hémangiomes
Description	None
Rubrique	Identification de l'urgence
Contributeurs	Sophie Blaise
Ordre	4

· 10 % des hémangiomes infantiles se compliquent (cf 6 situations ci-dessous) et nécessitent

o Un avis et un suivi spécialisé

o un traitement précoce (le traitement de première intention dans ces cas est le **propranolol per os)**

Figure 113.4 : hémangiome ulcéré

1- Ulcération

L'ulcération fait suite à une nécrose partielle de l'hémangiome (Figure 113.4). Les localisations à risque sont: le siège (fesses, vulve), les lèvres, les plis (cou).

Conséquences possibles :

- douleurs, majorées par les mictions en cas d'atteinte du siège et gênant l'alimentation en cas de localisation péri orale;
- saignements
- cicatrice séquellaire

Figure 113.4 : hémangiome ulcéré

Figure 113.5 : hémangiome volumineux du visage avec risque de séquelle esthétique

2- Hémangiomes orbito-palpébraux

Risque d'amblyopie fonctionnelle par occlusion du champ visuel et/ou déformation de la cornée (compression)

3- Hémangiomes de la pointe du nez, hémangiomes volumineux du visage (Figure 113.5) et de la région mammaire chez la fille

Risque de cicatrice séquellaire

Figure 113.5 : hémangiome volumineux du visage avec risque de séquelle esthétique

Figure 113.6 : hémangiome « en barbe » avec localisation sous glottique et dyspnée

4- Hémangiomes sous-glottiques

- Risque de détresse respiratoire par compression laryngée
- Peuvent être isolés ou associés à un hémangiome cutané *« en barbe »* (localisé symétriquement aux régions mandibulaires, mentonnière, cervicales et lèvre inférieure) => exploration endoscopique ORL nécessaire si hémangiome situé dans ces régions et avis spécialisé (Figure 113.6)

Figure 113.6 : hémangiome « en barbe » avec localisation sous glottique et dyspnée

5- Hémangiomatose miliaire

- Multiples petits hémangiomes disséminés de quelques millimètres à 1 cm de diamètre
- Peuvent être associés à des hémangiomes hépatiques parfois volumineux
- Demander une échographie abdominale et avis spécialisé

Annexe

Attendu d'apprentissage spécifique "de la situation abordée"	Domaines	Compétence générique
Interroger l'entourage sur le mode d'installation et l'évolutivité	Entretien/interrogatoire	Clinicien
Décrire les caracteristiques sémiologiques de la ou des "tâche(s)"	Stratégie diagnostique	Clinicien
Différencier un hémangiome infantile d'une malformation artério-veineuse ou capillaire	Stratégie diagnostique	Clinicien
Expliquer les phases évolutives d'un hémangiome infantile	Annonce	Communicateur
Identifier les hémangiomes à risque de complication	Examen Clinique	Clinicien
Diagnostiquer un naevus congénital	Stratégie diagnostique	Clinicien
Diagnostiquer une tache café au lait	Stratégie diagnostique	Clinicien

2 : attendus d'apprentissage spécifiques